Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Viamão

Rua Bento Gonçalves, 90 - Bairro: Centro - CEP: 94415700 - Fone: (51) 3098-5599 - Balcão Virtual (51) 99586-1221 - Email: frviamao3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5019325-88.2023.8.21.0039/RS

AUTOR: OLIVER SOBROZA DA SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))
RÉU: CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA

SENTENÇA

Vistos.

OLIVER SOBROZA DA SILVA, menor, representado por seu genitor TAYGO BONIEKE GUEDES DA SILVA, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais em face do **CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA**, partes qualificadas nos autos. Disse ser beneficiário de plano de saúde junto à demandada, através do plano empresarial Hospitalar Global Stand Empresarial – nº do Plano 0D9L1000092010, registro plano ANS 401616995 CCG2, Matrícula 243906, CNS 700806477770188. Narrou ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), conforme CID10 F84.0. Discorreu sobre a indicação de tratamento multidisciplinar. Aduziu ter apresentado pedido administrativo, não tendo obtido sucesso no fornecimento ou no ressarcimento dos custos do tratamento. Argumentou sobre o direito a reembolso dos valores suportados até o momento. Indicou o valor mensal necessário. Argumentou sobre a responsabilidade da requerida. Pugnou pela concessão da tutela de urgência para determinar à requerida que "forneça, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), o tratamento multidisciplinar indicado, conforme laudo médico em anexo, seja: Fonoaudióloga 1x semana; Psicóloga 1x semana; Psicopedagogia 1x semana; Terapia Ocupacional com integração sensorial 3x semana; Musicoterapia 1x semana; Fisioterapia 1x semana e Neurologista – a cada 6 (seis) meses, com o pagamento dos valores necessários para tanto, vez que inexiste rede credenciada e tendo o autor que recorrer a rede privada". Pugnou, ainda, que o tratamento seja mantido com os profissionais que já atendem a criança em virtude do vínculo já estabelecido e as demais especializadas e indicadas na presente demanda. Requereu a procedência da ação para confirmar a liminar pleiteada e para condenar a requerida ao reembolso integral das terapias já custeadas pela parte autora e todas as demais que eventualmente forem pagas desde a data do ajuizamento da presente ação até sua decisão final. Pediu a concessão da AJG. Juntou documentos.

A gratuidade de justiça foi deferida (evento 3, DESPADEC1).

Intimado, o Ministério Público apresentou parecer opinando pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada (evento 9, PROMOÇÃO1).

A medida liminar foi deferida e o ônus da prova invertido (evento 12, DESPADEC1).

Opostos embargos de declaração pelo autor (evento 18, EMBDECL1), restou acolhido (evento 20, DESPADEC1)

Interposto Agravo de Instrumento pela parte ré, foi dado provimento para afastar o dever de cobertura de musicoterapia e psicopedagogia (evento 37, DESPADEC1).

Citada, a parte ré apresentou contestação (evento 36, CONT1). Sustentou não ter negado o tratamento requerido pela parte autora, mas que disponibilizado em rede apta em cidade limítrofe, isto é, Porto Alegre. Afastou o dever de indenizar. Pleiteou a improcedência do feito. Acostou documentos.

Houve réplica (evento 70, RÉPLICA1).

Instadas as partes sobre a provas a produzir (evento 81, DESPADEC1), nada postularam.

Intimado para parecer final, o MP opinou pela procedência do feito (evento 99, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

O feito tramitou regularmente, estando autorizado seu julgamento, observado o disposto no art. 355, I do CPC.

Pretende, o demandante, a cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) que lhe foi diagnosticado.

Registro, inicialmente, que ao caso em tela se aplica a legislação consumerista, pois o autor e a ré enquadram-se como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A existência de contrato de assistência à saúde faz incidir as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o disposto no artigo 3º, parágrafo 2º do diploma consumerista.

Art. 3° ...

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Ademais, tal entendimento encontra-se consubstanciado no texto da Súmula 469 do STJ, que assim disciplina: *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".*

Pois bem. Nos termos da decisão que deferiu a medida liminar (evento 12, DESPADEC1), a qual, por oportuno, transcrevo, comprovada a indicação do tratamento multidisciplinar ao requerente. Vejamos:

Com relação à probabilidade do direito pleiteado, entendo que os documentos que acompanham a inicial demonstram a qualidade de segurado da parte autora (evento 1, OUT6), a existência da patologia referida na inicial e a recomendação do tratamento descrito na inicial (evento 1, ATESTMED7) e a dificuldade de obtenção de cobertura na esfera administrativa (evento 1, EMAIL8 a evento 1, EMAIL12).

Afora isso, no caso concreto, a documentação acostada aos autos comprova a enfermidade da qual o infante convalesce, bem como demonstram, em juízo perfunctório, que o autor se encontra em tratamento, sendo que por certo, a falta da intervenção terapêutica recomendada poderá causar sérios problemas ao autor.

Conforme prevê o art. 4º da Resolução Normativa nº 259/11 da ANS, é obrigação do plano de saúde fornecer os tratamentos pela sua rede credenciada, a qual deve se submeter o autor. E, inexistindo atendimento na rede credenciada, pode, o autor, optar por outro prestador de serviço às expensas da requerida, observando as coberturas contratadas. *In verbis:*

Art. 4º ***Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em****: (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)*

I - ***prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município****; ou* ***(Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)***
II - ***prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)***

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes*.* ***(Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)*** *(grifei)*

§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º. ***(Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)***

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las. ***(Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)***

Por outro lado, existindo profissional capacitado na rede credenciada e pretendendo a parte demandante permanecer vinculada ao profissional particular livremente escolhido, o reembolso deverá observar os limites previstos no contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, recolho da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL. TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE DOMICILIAR E ESCOLAR. AFASTADO. REDE CREDENCIADA. 1) No tocante ao Assistente Terapêutico, por sua vez, ao menos neste momento de cognição sumária, a negativa de ***cobertura*** *pela operadora do plano de saúde não se revela abusiva, nem infringe as determinações da Lei n. 9.656/98. 2) Na espécie, nos termos dos artigos 10 e 12 da Lei n. 9.656/98 e consoante entendimento jurisprudencial acerca da matéria, há duas situações em que a operadora do plano de saúde está obrigada a cobrir despesas domiciliares: quando o beneficiário necessita de tratamento com medicamentos antineoplásicos e quando necessita de home care, em substituição à internação hospitalar. 3) O acompanhante terapêutico em ambiente escolar deve ser providenciado pela instituição de ensino na qual o segurado frequenta, e não à administradora do plano de saúde, segundo se extrai do disposto na lei n. 13.145/2015. 4)* ***A opção do paciente em procurar atendimento fora da rede credenciada quando a operadora de plano de saúde possui profissionais para o atendimento, implica, somente, no reembolso dos valores nos limites da tabela do plano de saúde contratado entre as partes. 5) O reembolso integral das despesas somente é cabível quando se verificar alguma inexecução contratual por parte da operadora do plano ou abuso.*** *Situações não verificadas na hipótese, ao menos por ora. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR MAIORIA.(Agravo de Instrumento, Nº 52129165020248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 30-10-2024)*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO ABA E BOBATH. COBERTURA DEVIDA EM AMBIENTE CLÍNICO E POR PROFISSIONAL DA ÁREA DA SAÚDE. REEMBOLSO TRATAMENTO REALIZADO POR PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. LIBERALIDADE. REEMBOLSO NOS LIMITES DA CONTRATAÇÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer combinada com indenizatória, através da qual a parte autora busca cobertura integral do tratamento multidisciplinar realizado com profissionais não credenciados, bem como o reembolso dos valores gastos com o tratamento já em andamento, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) (CID 10: F84) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade — TDAH (CID 10: F90), julgada parcialmente procedente. Do tratamento multidisciplinar por método específico - Em consulta ao Parecer Técnico nº 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, relativo às coberturas - abordagens, técnicas e métodos - utilizados no tratamento do TEA, pode-se aferir que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a rigor, não descreve a técnica, abordagem ou método terapêutico a ser aplicado nas intervenções diagnóstico-terapêuticas a agravos à saúde sob responsabilidade profissional, permitindo a indicação, em cada caso, da conduta mais adequada à prática clínica, o que deve ficar a cargo do profissional assistente. De acordo com a Resolução Normativa n.º 539/2022, que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, com vigência a partir de 01º de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicando pelo médico assistente para tratamento do transtorno do espectro autista (TEA). Assim, é dever da operadora a cobertura do tratamento pelo método indicado pelo médico assistente, no caso: ABA E BOBATH. Do Assistente Terapêutico - O Acompanhamento Terapêutico caracteriza-se por atendimento, em regra, realizado no ambiente do paciente (casa, escola, outros espaços de convivência familiar e/ou social), ou seja, fora da clínica ou estabelecimento de saúde, visando à sua reinserção social e ao desenvolvimento de repertórios alternativos, entre outros. Em CASO DE necessidade de acompanhante terapêutico em ambiente escolar, incumbe à instituição de ensino QUE O segurado frequenta disponibilizar um profissional de apoio, e não à administradora do plano de saúde, a teor do disposto na Lei n.

13.145/2015.A cobertura do Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar e/ou domiciliar não está contemplada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e, portanto, DEVE ficar limitada ao ambiente clínico, realizada por profissional da área da saúde (psicólogo/terapeuta ocupacional), o que afasta o dever de cobertura pela operadora, do tratamento em ambiente natural (escola/domiciliar). Da realização do tratamento na rede credenciada oferecida pela operadora - No caso dos autos, há efetiva indicação, pela operadora, da sua rede credenciada, inclusas no programa TEA: Clínicas SOS Saúde e HD 360 Moinhos, ambas na cidade de Porto Alegre, onde reside o menor. Não obstante tais indicações, a parte autora optou por realizar o tratamento com profissionais não credenciados, ao argumento de que o médico assistente orientou a manutenção dos profissionais que já atendiam o menor em função do vínculo estabelecido. Inobstante às alegações da parte autora, inclusive quanto a ausência de horários compatíveis com a disponibilidade do menor, fato é que não restou comprovado nos autos a impossibilidade de utilização da rede credenciada, de tal modo que, a opção pelos profissionais que atendem o menor, se deu por liberalidade da parte autora, não podendo ser imputada à operadora as despesas decorrentes dessa opção. Do reembolso - ***Pelos termos do contrato, não há qualquer imposição para que o segurado se utilize dos profissionais e estabelecimentos constantes da rede referenciada, ou seja, o segurado poderá realizar os procedimentos médicos que necessitar com médicos/hospitais não referenciados e posteriormente obter o reembolso pela operadora, entretanto, desde que obedecidos os limites da apólice por ele contratada.Assim, o reembolso deverá se dar dentro dos limites da contratação e não de maneira integral como postulado.*** *Sentença reformada, no ponto. DUPLA APELAÇÃO. APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO, POR MAIORIA (Apelação Cível, Nº 51076124420238210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 02-08-2024)*

Com relação ao tratamento postulado, a Lei nº 12.764/212, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, enalteceu, mais precisamente, em seu art. 2º e 3º, a necessidade de tratamento multiprofissional desses cidadãos:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

I - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista;

II - a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação;

III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes;

[...]

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

[...]

Embora a parte ré sustente a não previsão dos tratamentos requeridos no rol da ANS, entendo que esta listagem elenca os procedimentos mínimos obrigatórios de cobertura, cabendo exclusivamente ao médico que acompanha o caso da parte indicar o tratamento adequado ao paciente a ser fornecido pelo plano de saúde, se a doença em si tiver cobertura.

Nesse sentido, embora no julgamento dos EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704, o Superior Tribunal de Justiça tenha considerado taxativo o rol de procedimentos da ANS, a Agência Reguladora publicou a Resolução Normativa nº 539, em 23.06.2022, que ampliou as regras de cobertura assistencial para TEA, regulamentando a cobertura obrigatória de quaisquer tratamentos indicados pelo médico assistente. Vejamos:

Art. 3º O art. 6º, da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4º, com a seguinte redação:

"Art. 6º (...) § 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento /manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Esse entendimento vem sendo adotado pelo nosso Tribunal de Justiça. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. HOME CARE. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. COBERTURA DEVIDA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a obrigação de a ora recorrente continuar prestando os serviços de home care. Ademais, destaca-se que é vedado ao plano de saúde recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, mesmo quando o contrato não prevê cobertura em ambiente domiciliar, pois cabe ao médico definir qual é o melhor tratamento para seu paciente. Ademais, há previsão de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, e não a forma como o tratamento será realizado. Precedentes. No caso em comento, nos termos do laudo médico de fls. 63/76, há expressa indicação do médico para que a parte autora tenha assistência domiciliar, pois a parte aora agravada é portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica, em estágio avançado e que necessita de que seja prestado o serviço de home care. O argumento elencando pela agravante, no sentido de que a pretensão da recorrida é a obtenção do serviço de home care apenas para cuidados básicos, não merece guarida, tendo em vista que a agravada necessita de cuidados especiais que não podem ser prestados apenas por familiares, conforme comprova, com precisão, os termos do laudo médico, acima transcrito. ***Ademais, importante salientar que incumbe exclusivamente ao médico que assiste ao paciente prescrever o tratamento de saúde que lhe é adequado, assim como a forma que este deverá ser prestado, não sendo dado ao plano de saúde imiscuir-se na relação médico-paciente. Outrossim, e mais importante, vale dizer que no caso concreto está em jogo a vida da pessoa humana, não podendo ser ceifada da agravada a oportunidade de ser tratada adequadamente da moléstia que a atinge.*** *Decisão fustiga mantida na íntegra. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO(Agravo de Instrumento, Nº 70080417819, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-03-2019)*

E também o STJ:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. ***PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA.*** *DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.*

(...)

6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).

7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).

8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.

9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.

10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.

11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos.

(STJ; REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)"

Evidencia-se, assim, a ilegalidade da negativa da ré, contrária ao direito fundamental à saúde, à vida e, também, ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Saliento que o reconhecimento do pedido inicial não se trata de assunção de riscos não contratados, mas sim de conferir interpretação adequada aos termos da avença, considerando a legítima expectativa do consumidor, com a adoção das técnicas disponibilizadas pela medicina para controle, prevenção e combate de doenças cobertas pelo plano de saúde.

Deste modo, conforme decisão liminar, deve a parte ré garantir ao autor o tratamento/terapias necessárias para o seu bem-estar, conforme laudo médico que acompanha a inicial.

Por fim, no tocante ao pleito de reeembolso, este é possível desde que comprovada a não disponibilização de atendimento na rede credenciada no município de residência do autor, o que, conforme já referido, comprovado nos autos.

Com objetivo de evitar que seus usuários permaneçam sem a devida assistência, as autorizações destes procedimentos para terapias específicas para autismo são pagas através de reembolso, observadas as regras do contrato vigente com o usuário (como carências, percentuais de coparticipações, etc), conforme previsto no inciso I, do artigo 1º da Lei 9.656/98.

Faz jus, portanto, a parte autora ao reembolso dos valores comprovadamente despendidos, a ser comprovado em cumprimento de sentença, na esteira do que dispõe a Lei dos Planos de Saúde, em seu artigo 12, inciso VI, pois prevista a modalidade de ressarcimento ao consumidor em virtude da carência de profissionais credenciados atuantes na área voltada ao tratamento do autismo na área geográfica de abrangência do contrato, a contar da data indicada no laudo médico contido no evento 1, ATESTMED7, que é apto a demonstrar a procura do tratamento junto à ré.

Inarredável, assim, o julgamento de procedência dos pedidos formulados.

Isso posto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, CONFIRMO a liminar e **JULGO PROCEDENTE** a ação movida por OLIVER SOBROZA DA SILVA em face de CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA, para:

a) **CONDENAR** a parte ré à manutenção da disponibilização e/ou custeio em favor do autor referente o tratamento terapêutico especializado interdisciplinar pleiteado - "Fonoaudióloga 1x semana; Psicóloga 1x semana; Psicopedagogia 1x semana; Terapia Ocupacional com integração sensorial 3x semana; Musicoterapia 1x semana; Fisioterapia 1x semana e Neurologista – a cada 6 (seis) meses";

b) **CONDENAR** a ré ao ressarcimento de valores eventualmente desembolsados pela parte contratante para o custeio do tratamento referido no item "a", além daqueles gastos no curso do processo, a contar da data indicada no laudo médico contido no evento 1, ATESTMED7, os quais deverão ser apresentados por mero cálculo em cumprimento de sentença, e deverão ser corrigidos pelo IGP-M, a contar de cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, os quais fixo em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8°, do CPC.

Em face da sistemática do Código de Processo Civil e da inexistência de juízo de admissibilidade, (art. 1010, § 3º do CPC), em caso de interposição de recurso de apelação, caso não seja intempestivo ou não haja o devido preparo, proceda-se na intimação da parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do RS.

Sentença publicada e registrada no sistema.

Transitada em julgado, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **LINIANE MARIA MOG DA SILVA, Juíza de Direito**, em 07/01/2025, às 19:46:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10074461958v6** e o código CRC **9b49f292**.